内科含诊断 收缩性心衰 ★★★（1~3题）

反应心功能

- 首选超声心动图（2007）：LVEF ≤ 40%
- 金标准右心漂浮 Swan-Ganz 导管：左心衰 PCWP ≥ 18、CI ≤ 2.2
- 脑钠肽（2017、2022）
  - 增高程度与严重程度正相关→评估心衰预后
  - NT-proBNP 正常可基本排除急性心衰、＜ 125 可基本排除慢性心衰
- X 线（2020）：肺门增大、上肺纹理增多、KerleyB 线（慢性间质性肺水肿）、肺门蝴蝶征（急性肺泡性肺水肿）

急性左心衰

高血压急症、急性心梗、急性心肌炎、急性瓣膜关闭不全等病史，突发呼吸困难、端坐呼吸、双肺湿啰音、咳粉红色泡沫痰

可能可能最可能

治疗（2022、2023）

- 湿暖型最常见（有明显淤血、无明显低灌注）
  - 血管扩张剂：硝普钠（高血压急症首选；二狭不用）、硝酸酯类、乌拉地尔、rhBNP“肖肖无奈”
  - 袢利尿剂：呋塞米、托拉塞米、布美他尼
- 湿冷型最严重（有明显淤血、有明显低灌注）
  - 收缩压＞ 90：血管扩张剂、袢利尿剂→正性肌力药
  - 收缩压＜ 90：正性肌力药（β-R 激动剂、磷酸二酯酶抑制剂、左西孟旦、毛花苷丙“按拢猛干”）
- 吗啡、高流量给氧、半卧或端坐位、抗凝等

慢性心衰的治疗（2008、2017、2018、2021、2024、2026）
降低死亡率（抗重构）：ACEI/ARB/ARNI（沙库巴曲缬沙坦），β-R 拮抗剂，醛固酮受体拮抗剂，SGLT-2i（格列净），sGC 刺激剂（维立西呱），伊伐布雷定（窦房结 If 电流抑制剂 - 房颤不用），CRT（适合收缩不同步、LVEF ≤ 35%、完左），ICD（预防恶性心律失常所致猝死）“ABQ 等五朵金花”

	用	不用（2007、2009、2015、2016）	注意
ACEI/ARB/ARNI	糖尿病、蛋白尿、痛风（ARB） 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压	①均不用：血 Cr ＞ 265、血钾＞ 5.5、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压“机甲吓人地” ②不用 ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风	不要将它们合用
β-R 拮抗剂	甲亢、快速型心律失常、肥心病 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压	急性心衰、NYHA IV级 病窦、二度 II 型和三度房室阻滞、预激综合征伴房颤 支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病“2234 都积极笑、变异咯”	必须保持体重恒定 伴明显肾功能不全用卡维地洛
血管扩张剂	不耐受 ACEI/ARB 者替代	肥心病、主狭、收缩压＜ 90、急性右室梗死	
利尿剂	心衰、高血压	急性右室梗死 痛风不用氢氯噻嗪	GFR ＜ 30 用呋塞米 合用排钾与保钾利尿剂（螺内酯 / 依普利酮 / 阿米洛利 / 氨苯蝶啶） 伴低血钠用托伐普坦、伴高血脂吲达帕胺比氢氯噻嗪好
强心苷	快房颤、房室结折返阵发性室上速（2015）	预激综合征、病窦、二度 II 型和三度房室阻滞、 急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期、二狭伴窦性心律 肥心病、主狭、用强心苷禁止电复律	